Flashcards — 40 cartes

Recto : question ciblée. Verso : réponse courte et explication pour mémoriser le raisonnement.

THÈME • Fondements et intentions

CARTE 01

Comment reconnaître une démarche de bientraitance ?

Réponse.

Respecter la personne dans sa singularité, tenir compte de ses besoins et évaluer l’effet des pratiques.

Explication.

La bientraitance recherche une réponse adaptée aux besoins de la personne et de son entourage et demande de réfléchir aux effets des actes.

CARTE 02

Pourquoi la bientraitance va-t-elle au-delà de l’absence de maltraitance ?

Réponse.

Parce qu’elle implique des choix concrets et positifs, centrés sur les besoins et le vécu de la personne.

Explication.

Ne pas maltraiter ne suffit pas : écouter, adapter, faire participer et considérer le vécu donnent un contenu positif à la bientraitance.

CARTE 03

Quelle réflexion mener avant une décision de soin restrictive ?

Réponse.

Comparer les bénéfices attendus et les risques pour la sécurité, l’autonomie, la dignité et la confiance.

Explication.

La réflexion bénéfices/risques ne porte pas seulement sur la sécurité immédiate : elle inclut aussi l’autonomie, la dignité et la confiance.

CARTE 04

Quels niveaux de bien-être une prise en soin doit-elle considérer ?

Réponse.

Le bien-être physique, psychologique et les priorités propres à chaque personne.

Explication.

L’approche décrite dans la séance associe bien-être physique et psychologique et accorde une place essentielle à ce qui compte pour le patient.

CARTE 05

Pourquoi questionner une habitude de service ?

Réponse.

Parce qu’une pratique habituelle peut ne pas correspondre aux besoins, au rythme ou aux choix d’une personne.

Explication.

Une habitude d’organisation ne garantit pas une pratique adaptée. La bientraitance demande de réexaminer la réponse proposée au regard du patient.

THÈME • Bénéfices, risques et contention

CARTE 06

Quel est l’intérêt pédagogique de l’exemple de contention ?

Réponse.

Confronter les bénéfices attendus aux risques physiques, relationnels et éthiques, sans en faire une indication de soin.

Explication.

Le scénario pédagogique de la contention confronte le bénéfice attendu à des atteintes possibles à l’autonomie, à la dignité et à la relation de confiance.

CARTE 07

Pourquoi une limitation des mouvements compte-t-elle dans le raisonnement éthique ?

Réponse.

Elle peut restreindre l’autonomie et le confort, même si un bénéfice de sécurité est recherché.

Explication.

Immobiliser une personne peut réduire ses possibilités d’action, y compris pour des gestes simples ; l’analyse doit intégrer cette conséquence.

CARTE 08

La tranquillité de l’équipe peut-elle suffire à justifier un choix restrictif ?

Réponse.

Non. La réflexion est centrée sur les bénéfices et les risques pour la personne et sur la nécessité de réévaluer.

Explication.

La sécurité de l’équipe ou sa sérénité ne remplacent pas une évaluation centrée sur la personne, ses droits et les effets possibles de la décision.

CARTE 09

Quels critères non techniques sont importants pour apprécier un soin ?

Réponse.

La confiance, le vécu, la dignité et les capacités que la personne peut conserver.

Explication.

Le lien de confiance et la préservation des capacités comptent dans l’analyse d’un soin, au même titre que ses effets physiques.

CARTE 10

Que faut-il éviter lorsqu’un exemple clinique sert à un débat éthique ?

Réponse.

Le transformer en protocole ou en consigne universelle sans évaluation propre à la situation.

Explication.

Le cas sert à faire raisonner les étudiants : il n’autorise pas une conduite clinique standardisée pour les patients agités.

THÈME • Personne, singularité et vulnérabilité

CARTE 11

Comment respecter la singularité d’une personne soignée ?

Réponse.

Identifier ce qui compte réellement pour elle, sans projeter ses propres priorités.

Explication.

La séance souligne que ce qui paraît simple au soignant peut avoir une grande valeur pour la personne et son bien-être.

CARTE 12

La difficulté à communiquer supprime-t-elle les préférences ?

Réponse.

Non. Le professionnel adapte l’écoute, l’observation et les moyens de communication.

Explication.

Une difficulté à communiquer accroît la vigilance nécessaire mais ne supprime ni la dignité ni la recherche des choix et capacités.

CARTE 13

Comment la vulnérabilité modifie-t-elle l’attitude professionnelle ?

Réponse.

Elle appelle une vigilance accrue, tout en respectant les capacités, les droits et la parole de la personne.

Explication.

La vulnérabilité appelle une protection respectueuse et une adaptation du soin, sans assimiler systématiquement la personne à une incapacité totale.

CARTE 14

Pourquoi un objet personnel comme des lunettes peut-il compter dans le soin ?

Réponse.

Parce qu’il peut préserver une capacité, une activité, l’autonomie ou la communication.

Explication.

Le commentaire oral sur la vidéo met en relation les lunettes, la possibilité de lire et la participation à la vie quotidienne.

CARTE 15

Comment préserver la place d’une personne qui répond peu ?

Réponse.

Expliquer, observer, laisser du temps et rechercher une forme de participation adaptée.

Explication.

L’absence de réponse immédiate ne dispense pas de rechercher une participation adaptée ; la réflexion porte sur le respect des droits et le vécu.

THÈME • Respect, dignité et autonomie

CARTE 16

Quels sont les cinq repères mis en avant dans l’enseignement ?

Réponse.

Personne et entourage ; dignité ; intimité ; autonomie ; sécurité physique et morale.

Explication.

La séance insiste sur la dignité, l’intimité, l’autonomie ainsi que le respect de la personne, de l’entourage et de la sécurité.

CARTE 17

Que signifie préserver l’autonomie dans un soin quotidien ?

Réponse.

Favoriser ce que la personne peut faire elle-même, lui proposer une aide proportionnée et respecter son rythme.

Explication.

La préservation de l’autonomie suppose de rechercher les capacités restantes et de limiter la substitution inutile.

CARTE 18

Quelle différence entre sécurité physique et sécurité morale ?

Réponse.

La première concerne les dangers corporels ; la seconde inclut l’isolement, la dévalorisation et le vécu relationnel.

Explication.

L’isolement et la non-reconnaissance de la personne peuvent nuire à son sentiment d’exister et à son bien-être moral.

CARTE 19

Comment se manifeste concrètement le respect de la dignité ?

Réponse.

Regarder, nommer, écouter et inclure la personne dans les échanges et les décisions.

Explication.

La dignité se traduit par des gestes et paroles qui reconnaissent la personne comme sujet, même en situation de dépendance.

CARTE 20

Pourquoi la sécurité physique n’est-elle pas le seul critère ?

Réponse.

Parce que l’autonomie, la dignité et la sécurité morale font également partie de la qualité du soin.

Explication.

Le soin peut protéger le corps et néanmoins compromettre la dignité ou le sentiment de considération : plusieurs dimensions sont à analyser.

THÈME • Communication, intimité et consentement

CARTE 21

Quelles étapes relationnelles précèdent une aide à la toilette ?

Réponse.

Frapper, se présenter, expliquer l’aide envisagée et rechercher l’accord de la personne.

Explication.

Frapper, se présenter, informer et rechercher le consentement donnent à la personne la place d’actrice de son soin.

CARTE 22

Pourquoi éviter les appellations familières imposées ?

Réponse.

Elles peuvent infantiliser ou effacer l’identité et les préférences de la personne.

Explication.

Un surnom familial imposé peut réduire une personne à son âge et ne tient pas compte de l’appellation qu’elle souhaite.

CARTE 23

Pourquoi éviter de parler à la place d’un patient ?

Réponse.

Parce que son vécu et sa parole doivent être recherchés directement lorsque cela est possible.

Explication.

Répondre à la place de la personne la rend moins visible dans le soin et peut empêcher de connaître son expérience propre.

CARTE 24

L’intimité se limite-t-elle au corps ?

Réponse.

Non. Elle concerne aussi la pudeur, les affaires personnelles et les conditions dans lesquelles le soin est réalisé.

Explication.

Le respect de l’intimité concerne le corps, la pudeur, le cadre du soin et les affaires personnelles.

CARTE 25

Comment accueillir une demande affective d’une personne âgée ?

Réponse.

Sans jugement fondé sur l’âge, en écoutant ses souhaits et en recherchant une réponse respectueuse.

Explication.

La scène orale discute le droit au lien affectif et au contact, sans jugement lié à l’âge ou aux représentations du soignant.

THÈME • Soins techniques et prendre soin

CARTE 26

Quelle différence entre exécuter un soin et prendre soin ?

Réponse.

Prendre soin ajoute à l’acte la prise en compte de la personne, de ses besoins et de son vécu.

Explication.

Un soin ne se limite pas à exécuter un geste : le vécu de la personne et la communication comptent également.

CARTE 27

Comment un soin technique peut-il devenir un temps relationnel ?

Réponse.

Par l’écoute d’une parole ou d’un besoin exprimé pendant le geste, avec un ajustement adapté.

Explication.

Le soin technique est aussi une occasion de relation : une parole spontanée de la personne mérite une réponse attentive.

CARTE 28

Pourquoi la distribution d’un repas n’est-elle pas seulement logistique ?

Réponse.

Il faut considérer la capacité et les besoins d’aide de la personne pour effectivement se nourrir.

Explication.

Distribuer le plateau ne remplace pas l’accompagnement du repas : autonomie, besoins d’aide et vécu doivent être vérifiés.

CARTE 29

Peut-on prendre soin sans effectuer de geste technique ?

Réponse.

Oui : par la présence, l’écoute, l’information, le soutien et l’accompagnement d’activités adaptées.

Explication.

L’écoute, l’information, le lien et les activités adaptées ont une valeur relationnelle même sans acte technique.

CARTE 30

Que vérifier avant de se substituer à la personne dans une activité ?

Réponse.

Ses capacités restantes, sa préférence, l’aide utile et l’effet sur son autonomie.

Explication.

Le temps nécessaire ne doit pas à lui seul effacer la participation possible de la personne et le respect de ses capacités.

THÈME • Travail d’équipe et contexte institutionnel

CARTE 31

Pourquoi la bientraitance est-elle une responsabilité collective ?

Réponse.

Parce que les transmissions, l’organisation et les décisions d’équipe influencent la réponse aux besoins.

Explication.

La séance rappelle l’importance du travail en équipe, des transmissions, des projets de vie et des conditions institutionnelles.

CARTE 32

Quel est le rôle des transmissions dans la bientraitance ?

Réponse.

Partager les observations et besoins pour construire un accompagnement cohérent entre professionnels.

Explication.

L'enseignante met en avant les transmissions, les échanges d'équipe et l'attention aux projets de vie, notamment en structure.

CARTE 33

Comment agir quand l'organisation heurte les besoins d'une personne ?

Réponse.

Nommer la difficulté et rechercher collectivement une adaptation praticable.

Explication.

La contrainte d'organisation peut expliquer une difficulté mais n'empêche pas de chercher une réponse collective.

CARTE 34

Comprendre une contrainte revient-il à excuser un manquement ?

Réponse.

Non. Les conditions peuvent éclairer la situation, mais les besoins et droits de la personne demeurent centraux.

Explication.

Comprendre les facteurs collectifs ne revient pas à excuser un comportement inadapté. Il faut protéger la personne et réfléchir aux conditions de travail.

CARTE 35

Pourquoi connaître le projet de vie d'un résident ?

Réponse.

Pour prendre en compte ses habitudes, activités, souhaits et priorités dans l'accompagnement.

Explication.

Le projet de vie sert à connaître les préférences et à adapter l'accompagnement au-delà de la succession d'actes.

THÈME • Analyser et réajuster une situation

CARTE 36

Quelles étapes permettent d’analyser une interaction de soin ?

Réponse.

Observer les faits, identifier les besoins, nuancer l’impact possible et proposer un ajustement concret.

Explication.

Le raisonnement doit distinguer les faits, les effets possibles et les ajustements observables, sans réduire la situation à un jugement.

CARTE 37

Pourquoi l’orientation du corps pendant un échange compte-t-elle ?

Réponse.

Elle peut aider à reconnaître la personne comme interlocutrice et à rendre l’information compréhensible.

Explication.

Le regard, l’explication et la recherche de compréhension participent à la reconnaissance de la personne.

CARTE 38

Quelle différence entre observation et interprétation ?

Réponse.

L’observation décrit un fait ; l’interprétation propose une hypothèse à vérifier auprès de la personne.

Explication.

Observer une expression ou un silence ne permet pas d’affirmer un état interne ou une intention ; le ressenti doit être exploré.

CARTE 39

Pourquoi réévaluer après un changement de posture ?

Réponse.

Pour vérifier l’effet réel de l’ajustement et le corriger si nécessaire.

Explication.

L’évaluation de l’effet réel sur la personne fait partie du raisonnement : une bonne intention ne suffit pas.

CARTE 40

Quel mémo résume les gestes relationnels d’une posture bientraitante ?

Réponse.

Respecter, écouter, expliquer, demander, adapter et réévaluer.

Explication.

Le soin bientraitant articule dignité, autonomie, communication et réévaluation des effets des actions.